

# 맹장염과 급성 게실염, 응급 대응 가이드

맹장염(급성 충수염)과 급성 게실염 — 무엇이 다르고, 언제 응급실로 가야 하는지

# 갑자기 시작된 복통, 무엇을 의심해야 할까요

맹장염과 게실염은 시간 싸움입니다 — 일찍 알아차리면 합병증을 막을 수 있습니다

## ▲ 몇 시간 넘게 이어지는 복통

단순히 체한 것이 아니라 **수술이나 입원이 필요한 응급**일 수 있습니다.

## ⚡ 두 병 모두 터질 수 있습니다

시간이 지나면 장이 터져 배 안 전체에 염증(복막염)이 번질 수 있습니다. 맹장염은 평생 **약 7%**가 겪습니다.

## 👨‍👩‍👧 집에서는 구분이 어렵습니다

아픈 곳과 많이 생기는 나이가 다르지만, **진찰과 영상 검사(초음파·CT)**가 있어야 구분됩니다.



그림 · 왼쪽은 붉게 부은 맹장 끝(충수), 오른쪽은 대장 벽에 튀어나온 주머니(게실)의 염증입니다(설명용 그림).

Tip · 위험 신호를 알아 두면 응급실에 갈 때를 놓치지 않습니다.

근거 · 대한외과학회 · 대한대장항문학회

## 맹장염(급성 충수염) — 이렇게 진행합니다

맹장 끝에 달린 작은 관(충수)이 막히고 염증이 생겨 부풀어 오르는 병입니다

**1**

### 입구가 막힘

시작

대변 덩어리나 림프 조직이 커져  
충수 입구가 막히고 점액이  
고입니다.

**2**

### 배꼽 주변 통증

처음 몇 시간

세균이 늘며 염증이 시작되고,  
처음에는 배꼽 주변이 막연히  
아픕니다.

**3**

### 오른쪽 아랫배로 이동

4~12시간

통증이 오른쪽 아랫배로 옮겨 가 한  
곳이 뚜렷하게 아파집니다.

**4**

### 터질 위험

24시간 이후

치료가 늦어질수록 충수가 터져  
복막염으로 번질 위험이 크게  
늘어납니다.

**10~30대에 가장 흔합니다** 그러나 어느 나이에나 생길 수 있고, 고령·소아는 증상이 약하게 나타나 장염처럼 보일 수 있습니다.

Tip · 통증이 옮겨 가는 모습은 맹장염의 대표적인 신호입니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · 광교바른내과 맹장염 안내문

# 급성 게실염 — 대장 벽 주머니에 생긴 염증

대장 벽의 약한 곳이 주머니처럼 튀어나온 것이 '게실'입니다

## 게실은 흔하고 대부분 증상이 없습니다

평생 모르고 지내기도 합니다. 입구가 막히고 세균이 늘면 **급성 염증**이 생깁니다.

## 한국인은 오른쪽이 흔합니다

서양인은 왼쪽이 흔하지만, 한국인은 **맹장 근처 오른쪽**에 많아 맹장염과 헛갈리기 쉽습니다.

## 위험 요인

나이가 많을수록 늘고, 기름진 식사·변비·비만이 위험 요인으로 알려져 있습니다.

## 합병증

터짐·고름주머니·장과 장 사이 찢길·장이 좁아짐으로 진행할 수 있어 **영상 검사**로 확인합니다.



그림 · 두 병 모두 아랫배 통증으로 올 수 있어 겉모습만으로는 구분이 어렵습니다(설명용 그림).

Tip · 오른쪽 아랫배가 아프다고 모두 맹장염은 아닙니다 — 진찰과 검사로 구분합니다.

근거 · 대한대장항문학회 · AGA 게실염 임상 업데이트 2021

## 맹장염과 계실염, 이렇게 다릅니다

증상은 비슷해 보여도 아픈 곳과 많이 생기는 나이가 다릅니다

### 맹장염(급성 충수염)

오른쪽 아랫배 — 배꼽 주변에서 시작해 옮겨 갑니다.

- 많은 나이 — 10~30대
- 주요 증상 — 입맛 없음·메스꺼움·옮겨 가는 통증
- 치료 — 수술로 떼어 내는 것이 표준
- 늦어지면 복막염·전신 감염(패혈증) 위험

VS

### 급성 계실염

왼쪽(서양) 또는 오른쪽(한국) 아랫배가 아픕니다.

- 많은 나이 — 중장년 이상
- 주요 증상 — 한 곳 누르면 아픔·열·변비나 설사
- 치료 — 장을 쉬게 하는 식사 조절·항생제(외래 또는 입원)
- 합병증이 있으면 고름 빼기·수술을 고려

Tip · 한국인의 오른쪽 계실염은 맹장염과 위치가 겹쳐 영상 검사로 구분합니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · AGA 계실염 임상 업데이트 2021

## 집에서 알아차릴 수 있는 여섯 가지 신호

한두 가지라도 해당되면 진료를 미루지 마세요

### 옮겨 가는 복통

배꼽 주변이 막연히 아프다가 4~12시간 뒤 오른쪽 아랫배로 옮겨 갑니다.

### 입맛 없음 · 메스꺼움

좋아하던 음식도 싫고 메스껍거나 토합니다.  
체한 것과 달리 시간이 지나도 안 좋아집니다.

### 움직이면 더 아픔

건거나 기침할 때, 발뒤꿈치로 바닥을 디딜 때  
아랫배가 찌릿하면 배 안쪽이 자극된 신호입니다.

### 한 곳이 뚜렷하게 아픔

손가락 하나로 짚을 수 있는 곳이 아픕니다. 오른쪽  
게실염도 맹장 근처에서 이렇게 아픕니다.

### 미열 → 고열

처음에는 37.5~38°C 미열로 시작해 38°C 넘게  
오르면 염증이 진행했을 수 있습니다.

### 약을 먹어도 계속됨

장염약·복통약을 먹어도 좋아지지 않고 통증이  
계속되면 같은 날 다시 진료를 받습니다.

Tip · 고령이나 어린이는 통증·열이 약해 장염처럼 보일 수 있으니 더 주의하세요.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · 광교바른내과 맹장염 안내문

## 배를 눌러 보는 확인은 의료진에게 맡기세요

집에서 반복해 누르며 확인하지 말고, 진료실에서 아래 순서로 확인합니다



그림 · 아픈 배를 스스로 거듭 누르지 말고, 멈춘 뒤 진찰을 받습니다.

Tip · 반복해서 누르면 통증을 키울 수 있습니다 — 아프면 누르지 말고 바로 진료를 받으세요.

### 1 진찰 **의료진**

아픈 곳을 누르고 땄 때 통증이 더 심해지는지(복막 자극)를 의사가 확인합니다.

### 2 피검사 **염증 수치**

백혈구·염증 수치(CRP)가 올라 있는지 봅니다.

### 3 영상 검사 **초음파·CT**

맹장·계실의 염증과 터짐·고름주머니가 있는지 확인합니다.

### 4 치료 결정 **외래·입원·수술**

진찰·피검사·영상·증상 경과를 모아 치료 방법을 정합니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · ACR 적정성 기준

## 가장 정확한 검사는 복부 CT입니다

진찰·피검사와 함께 영상 검사로 확인합니다

# 98%

환자를 찾아내는 비율

CT의 민감도 — 병이 있을 때 찾아냄

# 97%

아닌 사람을 가려내는 비율

CT의 특이도 — 병이 없을 때 없다고 봄

# 96%

전체 정확도

CT로 맞게 진단하는 비율



### 복부 초음파는

민감도 약 85%, 특이도 90%, 정확도 83%로 CT보다 낮지만 **방사선이 없어**  
임신부·어린이의 첫 검사로 씁니다.



### 영상만으로 100%는 아닙니다

진찰·피검사(백혈구·염증 수치)·증상 경과를 **함께 보고** 판단합니다.

Tip · 어떤 검사를 먼저 할지는 나이·임신 여부·증상 정도에 따라 의사가 정합니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · ACR 적정성 기준

# CT와 초음파, 어떻게 고를까요

환자 상황(나이·임신·증상 정도)에 따라 고릅니다

|          | 복부 CT                             | 복부 초음파                              |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 장점       | 가장 객관적이고 정확합니다. 터짐·고름주머니 확인에 좋습니다 | 방사선이 없어 임신부·어린이·반복 검사에 안전합니다        |
| 단점       | 방사선에 노출되고 조영제 알레르기가 있을 수 있습니다     | 비만·가스가 많으면 잘 안 보이고, 검사자에 따라 차이가 큼니다 |
| 먼저 쓰는 경우 | 성인, 심한 경우가 의심될 때                  | 임신부·어린이, 빨리 확인이 필요할 때               |



그림 · CT(왼쪽)와 초음파(오른쪽) — 상황에 맞는 검사를 고릅니다(설명용 그림).

Tip · 임신 가능성이 있으면 검사 전에 꼭 알려 주세요.

근거 · ACR 적정성 기준 · WSES 예루살렘 지침 2020

## 의원 외래로 갈까, 응급실로 갈까

시간이 아니라 증상으로 판단합니다 — 응급실 칸의 신호가 하나라도 있으면 바로 응급실로 가세요

### 의원 외래 진료 가능

오른쪽 아랫배 통증 없이 가볍게 불편할 때

- 명치·배꼽 주변이 가볍게 불편함
- 메스꺼움·미열이 없거나 약함
- 입맛이 약간 떨어진 정도
- 진찰·피검사·복부 초음파 → 결과에 따라 입원·수술 결정

VS

### 응급실로 가야 함

아래 중 하나라도 있을 때

- 오른쪽 아랫배 통증, 또는 누르다 땄 때 더 아픔(반발 압통)
- 38°C 이상 열·오한
- 배가 단단해지거나 움직일 때 더 아파 걷기 어려움
- 응급실에서 진찰과 CT 등 영상 검사 여부를 바로 확인

Tip · 통증이 시작된 시각을 적어 두면 진료 때 판단에 큰 도움이 됩니다.

근거 · 광교바른내과 맹장염 안내문 · WSES 예루살렘 지침 2020

## 이럴 때는 바로 119 — 지체 없이 응급실로

배 안 전체에 염증이 번졌거나 장이 터졌다는 위험 신호입니다

### 배가 판자처럼 딱딱해짐

배 전체가 굳으면 복막염 신호입니다. 터진 맹장·게실에서 장 내용물이 샌 상태입니다.

### 의식이 흐림 · 식은땀 · 맥이 빠름

전신 감염·쇼크 신호입니다. 혼자 두지 말고 **119 구급차**로 이동하세요.

### 통증이 잠깐 사라졌다 다시 심해짐

터지는 순간 통증이 줄었다가 배 전체로 퍼질 수 있습니다 — 좋아진 것이 아닙니다.

### 항문 출혈이 많음 · 검은 변

게실 출혈일 수 있습니다. 어지럽거나 쓰러질 것 같으면 119, 직접 운전하지 말고 금식합니다.

Tip · 이 신호는 기다리지 않습니다 — 직접 운전하지 말고 구급차를 부르세요.

근거 · WSES 복막염 지침 · 광교바른내과 맹장염 안내문

## 복통이 시작된 시각을 기억하세요

진단에 큰 도움이 됩니다 — QR을 스캔하면 이 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

### **광교바른내과**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

### **이 자료의 성격**

갑작스러운 복통으로 걱정하시는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

### **참고한 자료**

WSES 예루살렘 지침 2020 · WSES 복막염 지침 · AGA 게실염 임상 업데이트 2021 · ACR 적정성 기준 · 대한외과학회 · 대한대장항문학회 · 광교바른내과 맹장염 안내문



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 휴대폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요